



Trabajo Fin de Grado en Psicología
Universidad de Sevilla

Miguel Noguer Escudero

**La persuasión encubierta de las metáforas: un estudio experimental sobre su influencia
en la percepción de los trastornos mentales y los marcadores psicolingüísticos de su
efecto**

1 de Julio de 2026

Mercedes Cubero Pérez
Samuel Arias Sánchez

Declaración de Autoría responsable

Apellidos y Nombre: Miguel Noguer Escudero

Número de DNI: 29539682T

DECLARO bajo mi responsabilidad que

Este proyecto fue escrito por mí y con mis propias palabras, a excepción de las citas procedentes de las fuentes referenciadas que están claramente indicadas y reconocidas como cita textual. Tengo constancia de que la incorporación de material público sin su correspondiente cita, la paráfrasis de este material sin referenciar o la utilización de textos, imágenes, metodologías, datos o resultados procedentes de algún trabajo previo o del que no sea autor/a individual, se considera plagio y por lo tanto es susceptible de conllevar el suspenso en el trabajo o la asignatura, así como posibles medidas disciplinarias. Por ello he tenido cuidado en citar cualquier texto, imagen, figura, tabla o ilustración que no sea consecuencia de mi propia investigación, observación o redacción.

Declaro explícitamente que no he recurrido a sistemas de Inteligencia Artificial, como generadores de texto o herramientas de redacción automática, para la redacción de cualquier parte de este trabajo. Soy consciente de la creciente disponibilidad y capacidad de estas herramientas para generar contenido que puede parecer auténtico y original. Sin embargo, entiendo la importancia de la autenticidad, el esfuerzo personal y la integridad académica, y por ello me he abstenido de utilizar dichas tecnologías en la redacción de este proyecto.

Cualquier similitud con contenidos generados por sistemas de Inteligencia Artificial es puramente accidental y no intencionada.

Por otro lado, asumo que el profesorado podrá utilizar herramientas de control del plagio que garanticen la autoría de este trabajo.

En Sevilla, a 1 de julio de 2026.

Cláusula de confidencialidad

Yo, D. Miguel Noguer Escudero con DNI 29539682T, declaro expresa y formalmente conocer:

(1) La obligación de guardar secreto en relación con todos aquellos datos de carácter personal, que como consecuencia del desempeño de mis tareas en el ámbito del Trabajo Fin de Grado pueda tener conocimiento, según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). Esta obligación se mantendrá incluso después de finalizar mi relación con la Facultad de Psicología.

(2) La obligación de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias, y exigidas por la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, sobre toda la información con datos de carácter personal que maneje en el desarrollo de mis actividades académicas-profesionales, siendo irrelevante el soporte que la contenga.

(3) La propiedad intelectual de los datos utilizados en mi Trabajo Fin de Grado, que pertenece a Miguel Noguer Escudero, por lo que ninguno de estos datos podrá ser utilizado por mi parte en ninguna circunstancia salvo la defensa pública de mi Trabajo Fin de Grado.

(4) El reconocimiento de la propiedad intelectual compartida del Trabajo Fin de Grado con las tutelas del trabajo Mercedes Cubero Pérez y Samuel Arias Sánchez, por lo que ni dicho trabajo ni parte de él (modificada o no) podrá ser publicado o presentando en ningún foro distinto al de la defensa pública del Trabajo Fin de Grado sin su consentimiento expreso y firmado, incluso aunque aparezcan como autores/as de tal publicación.

Y a estos efectos, declaro expresa y formalmente, mi compromiso de cumplir con el deber de confidencialidad, en los términos expresados anteriormente.

En Sevilla, a 1 de julio de 2026.

Fdo. D. Miguel Noguer Escudero

ÍNDICE

Resumen.....	5
Introducción.....	7
Método.....	12
Participantes.....	12
Diseño.....	12
Materiales.....	13
Procedimiento.....	14
Análisis de datos.....	14
Resultados.....	18
Estadísticos Descriptivos.....	18
Contraste de Hipótesis Principales.....	19
Análisis Exploratorio de Variables Moderadoras.....	23
Discusión.....	24
Conclusiones.....	29
Limitaciones del Estudio.....	30
Líneas Futuras de Investigación.....	31
Referencias.....	33
Anexo A.....	36
Anexo B.....	38
Anexo C.....	41

Resumen

El presente estudio examina la influencia del enmarcado metafórico sobre la percepción de los trastornos mentales. Parte de una réplica conceptual del quinto experimento de Hendricks et al. (2018), contrastando el efecto de las metáforas de batalla y viaje al describir a un sujeto con depresión. Además, extiende el paradigma a la ansiedad usando dos nuevas metáforas (parásito y semilla), y examina el carácter encubierto de la persuasión analizando las atribuciones de los participantes y marcadores psicolingüísticos en sus respuestas textuales. Los participantes leyeron dos textos estructuralmente equivalentes y respondieron a cinco ítems en escala Likert asociados a cinco constructos: atribución de culpa interna, capacidad de aceptación, control percibido, búsqueda de apoyo emocional y juicio social atribuido al entorno, acompañados de una pregunta abierta de justificación. Los resultados replicaron los efectos del estudio original en el bloque de depresión, condicionando significativamente las respuestas hacia percepciones opuestas según la metáfora recibida. En el bloque de ansiedad se observaron efectos significativos sobre la aceptación, el control percibido y la búsqueda de apoyo, mientras que la culpa interna y el juicio social siguieron la dirección predicha sin alcanzar significación estadística. El análisis psicolingüístico de las respuestas textuales confirmó el carácter encubierto del efecto, pues la gran mayoría de los participantes no reconoció la influencia del lenguaje. Además, la magnitud individual de la persuasión se correlacionó negativamente con el uso de verbos cognitivos y la mención de creencias generales sobre los trastornos. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos para la comunicación clínica, la psicoeducación y la mitigación del estigma asociado a los trastornos mentales.

Palabras clave: enmarcado metafórico, metáfora conceptual, persuasión encubierta, depresión, ansiedad, estigma

Abstract

This study examines the influence of metaphorical framing on the perception of mental disorders. It builds on a conceptual replication of the fifth experiment by Hendricks et al. (2018), contrasting the effect of battle and journey metaphors when describing an individual with depression. It further extends the paradigm to anxiety using two novel metaphors (parasite and seed), and examines the covert nature of persuasion by analyzing participants' attributions of their responses and psycholinguistic markers in their open-ended answers. Participants read two structurally equivalent texts and responded to five Likert-scale items associated with five constructs: internal blame attribution, capacity for acceptance, perceived control, help-seeking behavior, and perceived social judgment, accompanied by an open-ended justification question. Results consistently replicated the effects described in the original study for the depression block, with framing significantly shifting responses toward opposing perceptions depending on the metaphor condition. In the anxiety block, significant effects were observed on acceptance, perceived control, and help-seeking, while internal blame attribution and perceived social judgment followed the predicted direction without reaching statistical significance. Psycholinguistic analysis confirmed the covert nature of the effect, as the vast majority of participants did not acknowledge the influence of language on their answers. Furthermore, individual persuasion magnitude correlated negatively with the use of cognitive verbs and the mention of general beliefs about mental disorders, a pattern interpretable in light of dual-process models of persuasion. The implications of these findings for clinical communication, psychoeducation, and the mitigation of stigma associated with mental disorders are discussed.

Keywords: metaphorical framing, conceptual metaphor, covert persuasion, depression, anxiety, stigma

Introducción

Las descripciones lingüísticas que se emiten sobre los trastornos mentales no son neutras, bien sea en el caso de un psicólogo comunicando su diagnóstico, medios de comunicación escogiendo los términos para hablar sobre una enfermedad, o conversaciones cotidianas cargadas de metáforas. El lenguaje configura sistemáticamente la descripción que el receptor del mensaje construye sobre el fenómeno que se le está describiendo (Sontag, 1979/2003). El presente estudio se basa en la tradición experimental llamada enmarcado metafórico, que ha documentado este fenómeno en diferentes dominios y poblaciones, y propone una examinación empírica de sus efectos en el ámbito de los trastornos mentales, cuya literatura e investigación es llamativamente más reducida en comparación con el de las enfermedades orgánicas (Hendricks et al., 2018; Thibodeau et al., 2017).

Durante siglos se ha concebido la metáfora como un recurso literario meramente decorativo, sin relación con el significado sustancial del contenido. Lakoff y Johnson (1980) revisaron esta concepción proponiendo que las expresiones metafóricas son en su lugar manifestaciones lingüísticas de correspondencias entre dominios conceptuales. Es decir, la metáfora sería un núcleo operativo de la cognición mediante el cual los conceptos abstractos se estructuran a partir de dominios fuente más concretos. Esta perspectiva confluyó con la contrastación empírica del enmarcado que realizaron Tversky y Kahneman (1981) al demostrar que las preferencias variaban en función de si un mismo escenario se presentaba en términos de ganancias o de pérdidas. Entman (1993) precisó el contraste definiendo el enmarcado como la dinámica comunicativa que otorga saliencia a ciertos atributos de la realidad. La intersección de ambas tradiciones da lugar al enmarcado metafórico, que ha sido estudiado experimentalmente con consistencia en las últimas dos décadas (Thibodeau et al., 2017).

Thibodeau y Boroditsky (2011, 2013) establecieron el paradigma al demostrar que presentar el crimen como una bestia que acecha o como un virus que infecta condicionaba las soluciones políticas de los lectores, con la metáfora animal promoviendo respuestas punitivas y la vírica respuestas preventivas y de rehabilitación, a pesar de que el resto del texto era idéntico. La mayoría de los participantes no identificó la metáfora como influyente y atribuyó sus respuestas a la información estadística, lo que llevó a caracterizar el enmarcado metafórico como un mecanismo de persuasión encubierta. El *Elaboration Likelihood Model* de Petty y Cacioppo (1986) permite interpretar el suceso, puesto que al presentarse como

implícita y no argumentativa, la metáfora se procesa por la ruta periférica, implicando que todo factor que incremente el procesamiento deliberado reducirá proporcionalmente su efecto persuasivo.

Este paradigma se ha aplicado en numerosos ámbitos, como política, economía, o educación, pero en lo que respecta a la salud, se ha hecho históricamente con dos sistemas metafóricos constantes. Por un lado, se observa la metáfora bélica, la cual presenta la enfermedad en cuestión como un enemigo o atacante, al paciente como un combatiente, y por ende al desenlace como una victoria o derrota. Este marco metafórico ha sido el dominante en el discurso público sobre el cáncer desde mediados del siglo XX (Sontag, 1979/2003). Por otro lado, se presenta la metáfora del viaje, que conceptualiza al paciente como un viajero, la enfermedad como recorrido y el desenlace como destino. Tal y como confirman los estudios de corpus realizados por la Universidad de Lancaster (Demmen et al., 2015; Semino et al., 2017), ambos sistemas coexisten en los discursos que se les otorga a los pacientes, familiares y profesionales sanitarios, a pesar de que la metáfora bélica sea la predominante.

Hendricks et al. (2018) examinaron las consecuencias de este contraste en el aspecto psicológico mediante una serie de cinco experimentos publicados en *Metaphor and Symbol*. En los primeros cuatro, se les presentó a los participantes unas viñetas que mostraban a un paciente y su situación oncológica, empleando el marco bélico en unos, y el del recorrido en otros. Posteriormente, respondieron un cuestionario que medía la atribución de culpa ante la no recuperación y la capacidad atribuida de hacer las paces con la situación. Se observó en los resultados que la metáfora bélica aumentaba de forma significativa la atribución de culpa al paciente y reducía la atribución de capacidad de aceptación, en comparación con el marco del viaje. En el quinto experimento, extendieron este paradigma al ámbito de la salud mental, sustituyendo el problema oncológico por una depresión y manteniendo el resto del texto idéntico, y los resultados sugirieron que el enmarcado metafórico funciona independientemente del dominio clínico específico, siempre que este admita ambas metáforas.

Estos hallazgos poseen unas implicaciones que resultan enriquecedoras más allá de lo estrictamente académico, debido a que si el lenguaje mediante el que se describe una enfermedad condiciona la culpa atribuida, dicho lenguaje es un determinante potencial para la experiencia subjetiva de un paciente, de la calidad de su red de apoyo, y por ende de su disposición a buscar y mantener el tratamiento. De igual forma, hay factores que reducen la susceptibilidad de un sujeto a ser persuadido, como el que se desarrolla en el *Common-Sense*

Model de autorregulación de la enfermedad por Leventhal et al. (2016). Postularon que las personas construyen representaciones cognitivas de las enfermedades en función de la experiencia e información disponible, y que a más consolidadas estén, menos susceptibles serán al enmarcado al procesarlo a través de su esquema previo, mientras que los que carezcan de ello, dependerán más del marco metafórico para organizar su procesamiento.

Sin embargo, hay una particularidad en los trastornos mentales y su concepción que los hace un dominio privilegiado teóricamente en cuanto a lo que el estudio metafórico refiere. A diferencia del cáncer o de las enfermedades cardiovasculares, cuya etiología orgánica está consolidada en la sociedad, los trastornos mentales se encuentran oscilando entre el modelo biomédico y las atribuciones asociadas a la falta de fuerza de voluntad, rasgos de personalidad, o debilidad personal (Pescosolido, 2013; Pescosolido et al., 2013). Específicamente, en lo que respecta a la población española, el informe *La situación de la salud mental en España* (Confederación Salud Mental España y Fundación Mutua Madrileña, 2023) evidencia que un porcentaje significativo de la población mantiene atribuciones causales basadas en la ausencia de fuerza de voluntad, especialmente en los casos de trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. La falta de claridad sobre este tema otorga una vital importancia a las metáforas que se utilizan en él, pues ante la ausencia de un consenso sobre la forma en la que la población considera su naturaleza, los marcos pueden hacer que se inclinen hacia una narrativa u otra.

Sin embargo, la aplicación de este modelo a la ansiedad introduce una complejidad conceptual adicional. La depresión posee una estructura narrativa con principio (diagnóstico), proceso (tratamiento) y posible desenlace (recuperación o no recuperación), mientras que tal y como observaron Penninx et al. (2011), la ansiedad tiene un curso clínicamente más crónico y fluctuante, de forma que las metáforas de trayecto y batalla no encajan de la misma manera con su fenomenología. Por ello, en este estudio, en lugar de aplicar el binomio batalla-viaje en el texto del paciente con ansiedad, se ha optado por establecer un nuevo bloque de metáforas que presentan la ansiedad como una semilla y como un parásito. Los dos marcos metafóricos presentan el mismo dominio narrativo: un organismo vivo que habita en el interior del paciente y utiliza su energía vital para alimentarse. La cuestión diferencial es que activan esquemas evaluativos contrarios, ya que la metáfora del parásito conceptualiza al paciente como un huésped involuntario de un agente que le invade y consume, mientras que la metáfora de la semilla lo hace como agente activo de un proceso vital que crece y se cultiva.

Adicionalmente, uno de los aspectos teóricos más característicos del enmarcado metafórico, su carácter encubierto, no ha sido apenas estudiado en el ámbito de los trastornos mentales. Si el efecto del enmarcado metafórico opera sin que el receptor identifique el lenguaje como elemento influyente en su juicio, la mera advertencia sobre el lenguaje a modo de concienciación resultaría insuficiente como estrategia de mitigación. Surge entonces la relevante cuestión de qué hace a algunos receptores más resistentes al efecto que otros, y una de las ventanas más privilegiadas para responder a ello reside en el lenguaje de los propios participantes. El lenguaje que los participantes producen al justificar sus respuestas permite medir variables como la densidad de verbos cognitivos, la elaboración de la respuesta o la mención explícita de creencias generales sobre el trastorno (marcadores que el *Elaboration Likelihood Model* y el *Common-Sense Model* vinculan a una mayor profundidad de procesamiento y activación de esquemas previos), y examinar si estas correlacionan con la magnitud individual de persuasión. Con este propósito, el presente estudio incorpora un análisis psicolingüístico de las respuestas textuales emitidas.

De forma añadida, hay un conjunto de variables individuales que pueden llegar a condicionar el tamaño del efecto. Xu (2024) observó que la edad avanzada se correlaciona con una mayor susceptibilidad al enmarcado, especialmente en marcos con connotación negativa; el nivel educativo correlaciona en sentido inverso (Garcia-Retamero y Galesic, 2010); las mujeres presentaron diferencias mayores entre condiciones metafóricas en la dimensión paz-culpa (Hendricks et al., 2018); la experiencia personal con el trastorno reduce la susceptibilidad al disponer ya de una representación mental consolidada (Thibodeau y Boroditsky, 2013); y la formación profesional, de forma contraintuitiva, no protege frente al efecto, dado que el procesamiento metafórico opera en niveles cognitivos que la formación técnica no consigue desactivar (Tabesh et al., 2019).

Sobre los antecedentes expuestos, el presente estudio plantea tres objetivos. El primero, replicativo, consiste en examinar si el efecto del contraste metafórico batalla-viaje sobre la atribución de culpa, aceptación, control, búsqueda de apoyo y juicio social, reproduce lo originalmente observado por Hendricks et al. (2018) en muestra hispanohablante en el dominio de la depresión. El segundo objetivo, extensivo, consiste en examinar si el contraste metafórico análogo diseñado específicamente para el dominio de la ansiedad, produce diferencias sistemáticas en las mismas variables dependientes. El tercer objetivo, complementario, consiste en examinar si la influencia del enmarcado metafórico opera de

manera encubierta (analizando si los participantes reconocen explícitamente la influencia del lenguaje del texto al justificar sus respuestas), y si ciertos marcadores psicolingüísticos individuales (densidad de verbos cognitivos, mención de creencias generales sobre el trastorno, y longitud de la respuesta) correlacionan con la magnitud individual de la persuasión. De manera adicional, se exploran cinco variables individuales: edad, sexo, nivel de estudios completado, experiencia personal con cada trastorno y formación previa en psicología o salud mental.

Con base en la literatura revisada, se formulan las siguientes hipótesis de trabajo. En el bloque de depresión, se predice que el marco bélico producirá una mayor atribución de culpa interna ante la no recuperación (H1), un mayor juicio social negativo del entorno (H2) y una menor disposición a buscar apoyo emocional (H3) que el marco de viaje, y que este último aumentará la capacidad atribuida de aceptación (H4) y reducirá el control percibido (H5) en comparación con el marco bélico. Esta última predicción se fundamenta en que el esquema conceptual de la batalla otorga al sujeto el rol de combatiente activo frente a un adversario sobre el que puede actuar, activando así la percepción de agencia sobre el curso del trastorno; el marco del viaje, en cambio, sitúa al protagonista ante un recorrido cuya dirección no controla enteramente. En el bloque de ansiedad, se predice que el marco de parásito incrementará la culpa interna (H6) y el juicio social (H7), y que el marco de semilla potenciará la aceptación (H8), la búsqueda de apoyo (H9) y el control percibido (H10). Respecto al carácter encubierto del efecto, se predice que la mayoría de los participantes no atribuirán sus respuestas al texto o la metáfora, sino a fuentes personales como la experiencia, las creencias o las inferencias sobre el caso (H11), y que la magnitud individual de la persuasión correlacionará negativamente con marcadores de procesamiento elaborativo, es decir: densidad de verbos cognitivos, mención de creencias generales y longitud de la respuesta (H12). De manera complementaria y con carácter exploratorio, se examina si el sexo, la edad, el nivel educativo, la experiencia personal con cada trastorno y la formación previa en psicología o salud mental modulan el tamaño del efecto, sin formular predicciones específicas dada la heterogeneidad de los hallazgos previos y el tamaño limitado de algunos subgrupos.

Método

Participantes

La muestra estuvo formada por 167 participantes adultos hispanohablantes reclutados mediante muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Los criterios de inclusión fueron la mayoría de edad y el dominio del español.

La edad media fue de 41.82 años ($DT = 16.58$), con un rango de 19 a 85 años y una mediana de 47 años. Respecto al sexo, 99 participantes se identificaron como mujeres, 66 como hombres, y 2 prefirieron no especificarlo. El nivel educativo fue predominantemente universitario: 53 participantes (31.7%) contaban con grado finalizado, 32 (19.2%) con grado en curso y 32 (19.2%) con máster o posgrado, frente a 27 (16.2%) con bachillerato o ciclo de grado medio, 13 (7.8%) con formación profesional de grado superior, 7 (4.2%) con doctorado y 3 (1.8%) con estudios obligatorios, agrupando primaria y ESO.

Respecto a la experiencia con los trastornos referidos, 20 participantes (12.0%) declararon haber sido diagnosticados o tratados por depresión y 36 (21.6%) por ansiedad. Además, 36 participantes (21.6%) refirieron tener formación en psicología o salud mental.

Diseño

Se empleó un diseño factorial mixto 2×2 con un factor entre participantes (combinación de marcos metafóricos: batalla + parásito vs. viaje + semilla) y un factor intra-participante (bloque del trastorno: depresión vs. ansiedad). Cada participante leyó dos viñetas y fue asignado a una de las dos combinaciones de marcos metafóricos: bélico + parásito o viaje + semilla. La asignación se realizó en función de la paridad del mes de nacimiento (par: batalla + parásito; impar: viaje + semilla), criterio cuasi-aleatorio que evita la autoselección. Este procedimiento dio lugar a dos grupos de tamaño desigual ($n = 70$ y $n = 97$, respectivamente). No obstante, al basarse la asignación en la paridad del mes de nacimiento, criterio independiente de cualquier característica del participante, no cabe esperar sesgo sistemático entre condiciones; en efecto, ambos grupos resultaron equivalentes en las variables sociodemográficas registradas (edad, sexo, nivel educativo, experiencia previa con cada trastorno y formación en psicología), sin diferencias estadísticamente significativas entre ellos, lo que respalda su comparabilidad pese a la desigualdad de tamaño.

Materiales

Para el bloque de depresión se utilizaron los textos de las viñetas del quinto experimento de Hendricks et al. (2018) traducidas al español. Ambas versiones describían el caso de Marcos, recientemente diagnosticado de depresión. Se conservaron las metáforas originales y su diferencia en seis términos pertenecientes al campo metafórico correspondiente: la condición bélica recurría al sistema de la batalla (batalla, lucha, campo de batalla, librar, historias de batalla) y la condición de recorrido al del viaje (viaje, camino, sendero, recorrer, historias de viaje)

Para el bloque de ansiedad se diseñaron dos textos propios que compartían estructura sintáctica e información factual, pero diferían en el marco metafórico (representado de nuevo mediante seis términos clave). La condición de parásito conceptualizó la ansiedad como un agente vivo que invade y consume la energía vital de la protagonista, Laura (parásito, organismo que la invade, infección, contagio), mientras que la condición de semilla la presentó como un proceso generativo interno (semilla, organismo que la habita, cultivo, crecimiento). Si bien las dos metáforas refieren la imagen de un organismo que se aloja en la protagonista, activan esquemas opuestos en cuanto a agencia, valencia y atribución causal, siguiendo el principio de isomorfismo estructural recomendado por Steen (2023). Los cuatro textos se recogen en el Anexo A.

Después de la lectura de cada texto, los participantes debían responder cinco ítems en escala Likert de siete puntos. En ellos se medía culpa interna ante la no recuperación, capacidad de aceptación, control percibido sobre el trastorno, disposición a buscar apoyo emocional y juicio social atribuido al entorno. Los anclajes específicos que representaban los valores mínimos y máximos de la escala variaron según el constructo (de *Nada* a *Completamente*, de *Ningún control* a *Control total*, de *Muy poco* a *Muchísimo*, y de *Nada probable* a *Muy probable*). El Anexo B recoge la redacción exacta de los diez ítems.

Además, tras los cinco ítems de cada bloque, los participantes respondieron a una pregunta abierta en la que justificaban sus respuestas. Esto permitió analizar a qué atribuían su juicio (elemento clave para evaluar el carácter encubierto de la persuasión del enmarcado) y obtener un corpus textual para realizar un análisis psicolingüístico.

Al final del cuestionario, los participantes respondieron seis ítems de índole sociodemográfica, los cuales recogían edad, sexo, nivel de estudios, antecedentes de diagnóstico o tratamiento por depresión, antecedentes por ansiedad y formación previa en psicología o salud mental.

Procedimiento

El cuestionario se administró exclusivamente en línea mediante la plataforma Google Forms, lo que permitió la recogida automática y anónima de las respuestas. La difusión del mismo se realizó a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El cuestionario comenzó mostrando una pantalla inicial que exponía la información del estudio y el consentimiento informado. Tras aceptarlo y responder al ítem de paridad del mes de nacimiento que determinó la condición experimental que se les asignó, leyeron la primera viñeta (depresión) y respondieron a sus cinco ítems Likert y a la pregunta abierta. Posteriormente, leyeron la segunda viñeta (ansiedad) y respondieron al bloque correspondiente, concluyendo con los seis ítems sociodemográficos.

Análisis de datos

Análisis de las Variables Likert

Para realizar el análisis de los datos obtenidos en los ítems tipo Likert, se empleó el software JASP versión 0.97 (JASP Team, 2026).

En primer lugar, se examinaron los estadísticos descriptivos de la muestra y se comprobó la equivalencia entre los grupos experimentales en las variables sociodemográficas mediante pruebas *t* de Welch para la edad y pruebas de chi-cuadrado para las variables categóricas. Posteriormente, se compararon las puntuaciones medias de las cinco variables dependientes entre las dos condiciones de cada bloque mediante pruebas *t* de Welch para muestras independientes. Se optó por la variante de Welch frente a la de Student porque, a diferencia de esta última, no asume homogeneidad de varianzas entre grupos, supuesto que resultaba poco plausible dado el tamaño desigual de los grupos ($n = 70$ y $n = 97$) y la heterocedasticidad observada en varias de las variables dependientes.

El tamaño del efecto se cuantificó mediante la *d* de Cohen, interpretada según los puntos de corte convencionales ($d = 0.20$ efecto pequeño; $d = 0.50$ efecto medio; $d = 0.80$ efecto grande). El nivel de significación se fijó en $\alpha = .05$ (bilateral).

Con el fin de explorar posibles efectos de moderación, se replicaron las pruebas *t* en cada subgrupo establecido por las variables sociodemográficas categóricas, y se compararon sus tamaños del efecto. Respecto a la variable continua edad, se calcularon coeficientes de correlación de Spearman entre la edad y cada variable dependiente, y se realizaron contrastes adicionales tras dividir en dos grupos la muestra en función de la mediana de edad.

Análisis de Contenido de las Atribuciones de la Fuente del Juicio

Se analizaron las 334 respuestas textuales (167 por bloque) en dos fases. En la primera, con la finalidad de clasificar las respuestas en función de la atribución que realizaban al justificar sus puntuaciones Likert, se desarrolló un análisis de contenido categorial deductivo (Bardin, 2002). Para definir las categorías, se utilizó el marco teórico sobre persuasión encubierta (Thibodeau y Boroditsky, 2013) que da lugar a cinco etiquetas no excluyentes entre sí: (a) atribución al texto, la metáfora o el lenguaje del estímulo; (b) atribución a experiencia personal con el trastorno; (c) atribución a experiencia con personas cercanas; (d) atribución a creencias generales sobre el trastorno; y (e) inferencias directas sobre el caso del protagonista.

Para llevar a cabo la codificación, se recurrió al análisis de corpus AntConc versión 4.2.4 (Anthony, 2023) debido a que permitió identificar sistemáticamente los marcadores léxicos asociados a las categorías mediante búsquedas de concordancia con listas de términos predefinidos. Dichas clasificaciones, de igual forma, se revisaron manualmente a modo de aseguración. Con base en las categorías de atribución, se estableció una variable compuesta denominada persuasión encubierta, que combina dos condiciones: no mencionar el texto como fuente y atribuir el juicio a una fuente personal. La inclusión del segundo requisito en esta variable se debe a que, si se considerase persuasión encubierta toda respuesta que no mencione el texto como causa, se correría el riesgo de categorizar erróneamente toda respuesta escueta, genérica, o que no justifica explícitamente su respuesta con nada. La codificación se sustentó en listas léxicas definidas a priori (Anexo C), lo que reduce la dependencia del juicio subjetivo del codificador y aumenta la replicabilidad del procedimiento: cualquier investigador que aplique las mismas listas con AntConc 4.2.4 obtendrá idéntica clasificación. No obstante, este procedimiento no sustituye a una codificación inter-jueces clásica, por lo que los resultados del análisis de contenido se interpretan con la cautela correspondiente y se discuten en la sección de Limitaciones. Dado que términos como *creo*, *pienso* o *considero* aparecen tanto en la lista de verbos cognitivos como en la categoría de creencias generales, se estableció el criterio operativo de que la categoría de creencias generales requería la presencia del marcador seguido de una proposición sobre el trastorno como clase (*creo que la depresión es..., pienso que la ansiedad suele...*), mientras que la categoría de verbos cognitivos se aplicó a cualquier ocurrencia del término con independencia de su complemento. El solapamiento resultante es una limitación del procedimiento que se reconoce en la sección correspondiente.

De forma complementaria, se realizó una búsqueda de los términos característicos de los cuatro marcos metafóricos, con el objetivo de cuantificar la posible reproducción del

campo metafórico del estímulo. Las listas léxicas utilizadas contemplaron tanto los propios términos presentes en los textos como variantes morfológicas y términos semánticamente próximos.

Dado que las cinco hipótesis de cada bloque son direccionales y se derivan a priori del marco teórico (Hendricks et al., 2018, y la estructura conceptual contrastiva de cada par metafórico), cada contraste se trata como una prueba independiente de una hipótesis específica y no como una exploración sobre un panel de variables. Por este motivo, no se aplicó corrección por comparaciones múltiples a los contrastes principales. Como verificación adicional, se comprueba que los efectos significativos resisten un criterio conservador de Bonferroni (α corregido = .01); los efectos con $p < .01$ son: culpa interna, juicio social y búsqueda de apoyo en depresión, y control percibido en ansiedad.

Análisis Psicolingüístico Cuantitativo de las Respuestas Textuales

En la segunda fase del análisis textual, se llevó a cabo un análisis psicolingüístico cuantitativo con la finalidad de identificar marcadores del procesamiento del lenguaje. Para ello, se siguieron las pautas que establecen Pennebaker y colaboradores para el análisis automatizado del lenguaje natural (Tausczik y Pennebaker, 2010), validadas para muestras hispanohablantes por Ramírez-Esparza et al. (2007). Cada respuesta se *tokenizó* y se calcularon la longitud en tokens, la diversidad léxica mediante la razón *type-token* y, de forma complementaria, los índices de Guiraud y de Maas, recomendados por su menor dependencia de la longitud del texto (Tweedie y Baayen, 1998).

Seguidamente, se cuantificó la presencia de las categorías psicolingüísticas en términos de densidad relativa (porcentaje de *tokens* por categoría). Con el fin de comprobar la H12, se consideraron las siguientes categorías: verbos cognitivos (que incluye creo, pienso, considero, opino, supongo, imagino, entiendo, asumo, sospecho, juzgo), entendidos como marcadores de metacognición explícita y de procesamiento por la ruta central según el *Elaboration Likelihood Model*; marcadores de tentatividad (quizá, quizás, tal vez, puede, podría, posiblemente, probablemente, parece) y marcadores de certeza (sé, seguro, claramente, obvio, evidente, claro, indudablemente), entendidos como indicadores de la postura epistémica del hablante respecto a su propio juicio; pronombres en primera persona del singular (yo, me, mí, mi, mío, mía, conmigo), entendidos como marcadores de autorreferencia; pronombres en tercera persona (él, ella, le, les, lo, la), entendidos como marcadores de atribución externa centrada en el protagonista de la viñeta; marcadores de causalidad (porque, pues, debido a, causa, motivo, razón, provoca, genera, produce, por tanto, entonces); negaciones (no, nada, nunca, jamás, ningún, tampoco, ni, sin); y términos del

campo léxico de la emoción negativa (triste, dolor, sufrir, miedo, angustia, desesperación, malestar, agobio, estrés) y positiva (bien, feliz, alegría, esperanza, tranquilo, calma, paz, aceptar, fortaleza).

Para cuantificar la magnitud individual del desplazamiento producido por el marco metafórico se construyó un índice por participante y bloque. Cada ítem Likert se recodificó previamente de modo que un valor alto reflejara la dirección hipotetizada para la condición experimental del participante: en las variables en las que la hipótesis predecía mayor puntuación bajo el marco recibido (p. ej., culpa interna bajo batalla, o control percibido bajo semilla) la puntuación se mantuvo en su escala original (1-7), mientras que en aquellas en las que la hipótesis predecía menor puntuación bajo el marco recibido (p. ej., aceptación bajo batalla, o culpa interna bajo semilla) la puntuación se invirtió ($x' = 8 - x$). Para situar el índice en torno a cero, cada puntuación recodificada se centró restándole 4 (el punto medio de la escala Likert de 7 puntos), y el índice individual de persuasión se calculó como la suma de los cinco valores centrados del bloque correspondiente. El índice puede así oscilar entre -15 y +15, donde valores positivos indican un desplazamiento del juicio individual en la dirección hipotetizada por el marco al que el participante fue expuesto, valores próximos a cero indican ausencia de efecto, y valores negativos indican un desplazamiento contrario a la dirección hipotetizada. La consistencia interna del índice, calculada como α de Cronbach sobre los dos bloques, mostró que los cinco ítems recodificados de cada bloque obtuvieron un $\alpha = .58$ (r medio inter-ítem = .22) en depresión y $\alpha = .67$ (r medio inter-ítem = .29) en ansiedad, valores que reflejan la heterogeneidad conceptual de los cinco constructos, esperada dado que el índice no pretende medir un factor único sino cuantificar el desplazamiento acumulado en dimensiones teóricamente distintas, y que se consideran suficientes para el uso exploratorio al que se destina.

Para estudiar la relación entre el índice individual de persuasión y los marcadores psicolingüísticos se aplicaron coeficientes de correlación de Spearman, debido a la distribución no normal de ciertas variables psicolingüísticas, especialmente las que presentan frecuencia léxica baja. Para profundizar en el patrón de las correlaciones, la muestra se dividió en tres grupos según el índice individual de persuasión del bloque de depresión: ausencia de efecto o efecto inverso (índice ≤ 0 ; $n = 59$), efecto moderado ($0 < \text{índice} \leq 5$; $n = 63$) y efecto pronunciado (índice > 5 ; $n = 45$). Los puntos de corte se establecieron con arreglo a criterios sustantivos (cero como umbral de ausencia de efecto neto y cinco como punto equivalente a un punto medio de desplazamiento por ítem) y no como percentiles empíricos, por lo que los grupos resultantes son de tamaño desigual. A efectos expositivos se

denominan terciles inferior, medio y superior. Se compararon los marcadores psicolingüísticos de los grupos extremos mediante prueba t de Welch. De igual forma, se examinó si la presencia o ausencia de estos marcadores presentaban asociación con el valor del índice de persuasión realizando pruebas t de Welch con la d de Cohen como tamaño de efecto.

Resultados

Estadísticos Descriptivos

La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las cinco variables dependientes en cada bloque experimental, separadas por condición. Las puntuaciones abarcaron todo el rango de la escala (1–7) en todas las variables, con desviaciones típicas comprendidas entre 1.30 y 1.94, lo que refleja una variabilidad adecuada. Las respuestas a las preguntas abiertas de justificación presentaron una longitud promedio de 22.9 palabras en el bloque de depresión y de 21.9 palabras en el bloque de ansiedad.

Tabla 1

Estadísticos Descriptivos de las Variables Dependientes por Condición Experimental

<i>Variable</i>	<i>Batalla</i> (<i>n</i> = 70)	<i>Viaje</i> (<i>n</i> = 97)	<i>Parásito</i> (<i>n</i> = 70)	<i>Semilla</i> (<i>n</i> = 97)	<i>Total</i> (<i>N</i> = 167)
<i>Bloque depresión</i>	<i>M (DT)</i>	<i>M (DT)</i>	—	—	<i>M (DT)</i>
Culpa interna	5.00 (1.30)	3.90 (1.91)	—	—	4.36 (1.76)
Aceptación	4.09 (1.57)	4.63 (1.46)	—	—	4.40 (1.53)
Control percibido	3.66 (1.60)	2.96 (1.50)	—	—	3.25 (1.57)
Búsqueda de apoyo	4.34 (1.55)	5.26 (1.42)	—	—	4.87 (1.54)
Juicio social	3.81 (1.89)	2.37 (1.66)	—	—	2.98 (1.89)
<i>Bloque ansiedad</i>	—	—	<i>M (DT)</i>	<i>M (DT)</i>	<i>M (DT)</i>
Culpa interna	—	—	4.27 (1.89)	3.76 (1.85)	3.98 (1.88)
Aceptación	—	—	3.77 (1.74)	4.40 (1.57)	4.14 (1.66)
Control percibido	—	—	3.67 (1.73)	4.51 (1.51)	4.16 (1.65)
Búsqueda de apoyo	—	—	4.24 (1.68)	4.80 (1.60)	4.57 (1.65)
Juicio social	—	—	3.99 (1.94)	3.66 (1.90)	3.80 (1.92)

Nota. Puntuaciones entre 1 (mínimo) y 7 (máximo). *M* = media; *DT* = desviación típica. Las condiciones batalla y parásito corresponden al mismo grupo (*n* = 70); viaje y semilla, al otro (*n* = 97).

Contraste de Hipótesis Principales

El bloque de depresión reveló diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones bélica y de viaje en la dirección hipotetizada en las cinco variables (Tabla 2).

Tabla 2

Contraste entre las Condiciones Batalla y Viaje en el Bloque de Depresión

<i>Variable</i>	<i>M Batalla</i>	<i>M Viaje</i>	<i>t</i>	<i>gl</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
Culpa interna	5.00	3.90	4.45	164.5	< .001***	0.66
Aceptación	4.09	4.63	-2.27	142.4	.025*	-0.36
Control percibido	3.66	2.96	2.86	143.1	.005**	0.45
Búsqueda de apoyo	4.34	5.26	-3.90	140.5	< .001***	-0.62
Juicio social	3.81	2.37	5.12	136.7	< .001***	0.82

Nota. Pruebas *t* de Welch para muestras independientes ($n_{\text{Batalla}} = 70$, $n_{\text{Viaje}} = 97$). $d = d$ de Cohen. * $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$.

Las cinco variables dependientes mostraron diferencias significativas en la dirección hipotetizada (Tabla 2). El marco bélico elevó la atribución de culpa interna, el control percibido y el juicio social negativo, siendo este último el efecto más intenso del estudio, y redujo la búsqueda de apoyo emocional. El marco de viaje, por su parte, incrementó la capacidad atribuida de aceptación. En conjunto, estos resultados evidencian que el tipo de metáfora utilizada influye de manera consistente en la percepción de la depresión y en las respuestas que suscita.

En síntesis, las cinco hipótesis del bloque de depresión quedan confirmadas: H1 (mayor culpa interna bajo el marco bélico; $d = 0.66$, $p < .001$), H2 (mayor juicio social negativo bajo el marco bélico; $d = 0.82$, $p < .001$), H3 (menor búsqueda de apoyo bajo el marco bélico; $d = -0.62$, $p < .001$), H4 (mayor aceptación bajo el marco de viaje; $d = -0.36$, $p = .025$) y H5 (mayor control percibido bajo el marco bélico; $d = 0.45$, $p = .005$) se cumplen en la dirección predicha y con significación estadística. La magnitud de los efectos observados respalda, además, la relevancia práctica de estas diferencias entre condiciones experimentales.

En el bloque de ansiedad, tres de las cinco variables dependientes mostraron diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones parásito y semilla, todas ellas

en la dirección predicha. La Tabla 3 reproduce los resultados, que se describen con mayor detalle a continuación.

Tabla 3

Contraste entre las Condiciones Parásito y Semilla en el Bloque de Ansiedad

<i>Variable</i>	<i>M Parásito</i>	<i>M Semilla</i>	<i>t</i>	<i>gl</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
Culpa interna	4.27	3.76	1.73	147.2	.086	0.27
Aceptación	3.77	4.40	-2.41	139.2	.017*	-0.38
Control percibido	3.67	4.51	-3.24	135.8	.002**	-0.52
Búsqueda de apoyo	4.24	4.80	-2.17	144.3	.031*	-0.34
Juicio social	3.99	3.66	1.08	147.2	.282	0.17

Nota. Pruebas *t* de Welch para muestras independientes ($n_{\text{Parásito}} = 70$, $n_{\text{Semilla}} = 97$). $d = d$ de Cohen. * $p < .05$; ** $p < .01$.

La condición semilla aumentó la atribución de capacidad de aceptación, de control percibido y de mayor búsqueda de apoyo emocional que la condición parásito (Tabla 3). La atribución de culpa interna y el juicio social siguieron la dirección predicha pero no llegaron a alcanzar significación estadística en los análisis de contraste ($p = .086$ y $p = .282$), mostrando también magnitudes de efecto marcadamente pequeñas. Asimismo, el bloque de ansiedad en conjunto presenta un patrón coherente con las predicciones que se habían formulado para el estudio.

En conjunto, de las cinco hipótesis específicas planteadas para el bloque de ansiedad se confirman tres: H8 (mayor aceptación bajo el marco de semilla; $d = -0.38$, $p = .017$), H9 (mayor búsqueda de apoyo bajo el marco de semilla; $d = -0.34$, $p = .031$) y H10 (mayor control percibido bajo el marco de semilla; $d = -0.52$, $p = .002$) alcanzaron significación estadística en la dirección predicha, con tamaños de efecto que oscilan entre pequeños y moderados. Por su parte, las hipótesis H6 (mayor culpa interna bajo el marco de parásito; $d = 0.27$, $p = .086$) y H7 (mayor juicio social bajo el marco de parásito; $d = 0.17$, $p = .282$) siguieron la dirección esperada pero no alcanzaron los umbrales de significación estadística requeridos, por lo que no quedan confirmadas de manera concluyente en esta muestra ni respaldan la propuesta.

Una vez establecido que el enmarcado metafórico modificó significativamente los juicios de los participantes en ambos bloques, se examinó si los participantes reconocían el

papel del lenguaje del estímulo al justificar sus respuestas, o si, por el contrario, atribuían sus juicios a fuentes personales independientes del estímulo. La Tabla 4 sintetiza la distribución de atribuciones identificadas mediante el análisis de contenido categorial deductivo (Bardin, 2002) con apoyo de AntConc 4.2.4 (Anthony, 2023) sobre las 334 respuestas textuales recogidas.

Tabla 4

Distribución de las Atribuciones de la Fuente del Juicio en las Respuestas Textuales (N = 167)

<i>Categoría de atribución</i>	<i>Depresión</i>	<i>%</i>	<i>Ansiedad</i>	<i>%</i>
	<i>n</i>		<i>n</i>	
Texto, metáfora o lenguaje	6	3.6	3	1.8
No menciona el texto	161	96.4	164	98.2
Experiencia personal	3	1.8	3	1.8
Experiencia con cercanos	4	2.4	5	3.0
Creencias generales	40	24.0	43	25.7
Inferencias sobre el caso	33	19.8	22	13.2
Persuasión encubierta	62	37.1	60	35.9

Nota. Las categorías no son mutuamente excluyentes. No menciona el texto: proporción de participantes que no aluden al lenguaje, las expresiones o las metáforas de la viñeta como fuente de su juicio. Persuasión encubierta: proporción de participantes que combinan la no mención del texto con la atribución del juicio a una fuente personal explícita (experiencia, creencia o inferencia sobre el caso).

La gran mayoría de los participantes no reconoció el papel del lenguaje del estímulo en sus respuestas: solo el 3.6% en el bloque de depresión y el 1.8% en el de ansiedad mencionaron explícitamente el texto, la metáfora o las expresiones empleadas como fuente de su juicio, de modo que el 96.4% y el 98.2% restantes, respectivamente, no aludieron al lenguaje del estímulo al justificar sus puntuaciones. La atribución más frecuente fueron las creencias generales sobre el trastorno, seguida de las inferencias directas sobre el caso del protagonista; la experiencia personal y la experiencia con cercanos constituyeron fuentes marginales. La persuasión encubierta en sentido estricto, definida como la combinación de no

mencionar el texto y atribuir el juicio a una fuente personal explícita, representó el 37.1% de las respuestas en depresión y el 35.9% en ansiedad.

Para examinar la asociación entre marcadores psicolingüísticos y la magnitud individual de la persuasión, se calcularon índices de persuasión por participante en cada bloque según lo descrito en la sección de Análisis de Datos. El índice presentó una media de 2.72 (DT = 5.28) en el bloque de depresión y de 1.57 (DT = 5.73) en el bloque de ansiedad, ambos significativamente superiores a cero (depresión: $t(166) = 6.67, p < .001$; ansiedad: $t(166) = 3.54, p < .001$). La Tabla 5 presenta las correlaciones de Spearman entre el índice individual de persuasión y los marcadores psicolingüísticos teóricamente relevantes.

Tabla 5

Correlaciones de Spearman entre Marcadores Psicolingüísticos y el Índice Individual de Persuasión

<i>Marcador psicolingüístico</i>	<i>Depresión</i>	<i>Ansiedad</i>
	ρ (p)	ρ (p)
Verbos cognitivos (% tokens)	-0.151 (.054)	-0.041 (.603)
Longitud de respuesta (tokens)	-0.125 (.109)	-0.104 (.181)
Marcadores de certeza	+0.046 (.561)	+0.007 (.924)
Marcadores de tentatividad	-0.059 (.457)	-0.022 (.781)
Pronombres 1ª pers. sing.	-0.001 (.990)	+0.071 (.364)
Marcadores de causalidad	-0.127 (.107)	-0.072 (.357)
Diversidad léxica (Guiraud)	-0.118 (.135)	-0.160 (.041)*

Nota. Correlaciones de Spearman entre cada marcador psicolingüístico y el índice individual de persuasión (valores positivos del índice indican mayor susceptibilidad al marco metafórico recibido). $N = 167$. * $p < .05$.

La densidad de verbos cognitivos correlacionó negativamente con el índice individual de persuasión en depresión ($\rho = -0.151; p = .054$), tendencia marginal en la dirección predicha por H12; el tercil menos susceptible (índice ≤ 0 ; $n = 59$) presentó un 2.04% de verbos cognitivos frente al 0.6 % del tercil más susceptible (índice > 5 ; $n = 45$). En ansiedad, la correlación siguió la misma dirección sin aproximarse a la significación. Quienes invocaron creencias generales sobre el trastorno presentaron índices de persuasión inferiores en ambos bloques, con un efecto significativo en ansiedad ($d = -0.47; p = .004$) y una

tendencia en la misma dirección en depresión ($d = -0.27$; $p = .106$). La longitud de la respuesta mostró una tendencia similar sin alcanzar significación en ningún bloque. Respecto a la reproducción léxica, el campo metafórico bélico apareció en ambas condiciones del bloque de depresión, $\chi^2(1) = 0.19$; $p = .666$. Sin embargo, en ansiedad apenas se reprodujeron los campos de parásito o semilla. En cuanto a la longitud de respuesta; no mostró significación estadística en relación con la persuasión. Adicionalmente, la diversidad léxica medida mediante el índice de Guiraud correlacionó negativamente con el índice de persuasión en el bloque de ansiedad ($\rho = -0.160$; $p = .041$), sin que esta asociación se reprodujera en depresión.

Análisis Exploratorio de Variables Moderadoras

Se examinó el papel modulador del sexo, la edad, la experiencia personal con cada trastorno, la formación previa en psicología y el nivel de estudios. No se aplicó corrección por comparaciones múltiples debido a la naturaleza exploratoria de estos análisis y el reducido tamaño de algunos subgrupos.

El sexo no modificó la magnitud global del efecto, sino su distribución entre variables. En el caso de la depresión, las mujeres mostraron efectos más pronunciados en juicio social, $d = 0.96$, $p < .001$, y culpa interna, $d = 0.77$, $p < .001$; los hombres en control percibido, $d = 0.86$, $p = .001$, búsqueda de apoyo, $d = -0.98$, $p = .001$, y aceptación, $d = -0.77$, $p = .003$. Respecto a la ansiedad, las mujeres mostraron un efecto significativo en control percibido, $d = -0.64$, $p = .002$, mientras que los hombres lo hicieron en búsqueda de apoyo, $d = -0.59$, $p = .026$.

Tras categorizar la muestra tomando como referencia la mediana de edad (47 años), los participantes más jóvenes mostraron en depresión efectos de magnitud grande en culpa interna, $d = 0.82$, $p < .001$, control percibido, $d = 0.75$, $p = .001$, y juicio social, $d = 0.83$, $p < .001$, y en ansiedad replicaron cuatro de las cinco hipótesis (culpa interna, $d = 0.67$, $p = .011$; aceptación, $d = -0.48$, $p = .038$; control percibido, $d = -0.78$, $p = .001$; búsqueda de apoyo, $d = -0.57$, $p = .018$). Los participantes de mayor edad mostraron efectos significativos únicamente en el bloque de depresión. De forma complementaria, la edad correlacionó negativamente con la culpa interna, $\rho = -0.176$, $p = .024$.

La experiencia personal con el trastorno actuó como factor protector ante el marco. En depresión, los participantes sin experiencia ($n = 144$) replicaron los cinco efectos principales

(d entre 0.43 y 0.90; todas $p < .05$), mientras que los participantes con experiencia ($n = 20$) no alcanzaron significación en ningún contraste (se excluyeron quienes prefirieron no especificar este dato). En cuanto a la ansiedad, los participantes sin experiencia ($n = 127$) exhibieron efectos significativos en cuatro variables (culpa interna, $d = 0.57$; aceptación, $d = -0.54$; control percibido, $d = -0.58$; búsqueda de apoyo, $d = -0.46$; todas $p < .05$), mientras que los participantes con experiencia ($n = 36$) presentaron un efecto marginal de signo inverso en culpa interna, $d = -0.67$, $p = .058$.

La formación previa en psicología o salud mental no protegió frente al efecto. En depresión, los participantes con formación ($n = 36$) mostraron en culpa interna un efecto de mayor magnitud, $d = 1.10$, $p = .003$, que los participantes sin formación, $d = 0.57$, $p < .001$; en ansiedad, los participantes con formación no alcanzaron significación en ninguna variable, mientras que los participantes sin formación replicaron cuatro de las cinco hipótesis. En cuanto al nivel de estudios, los participantes universitarios ($n = 124$) mostraron efectos significativos en cuatro variables del bloque de depresión y en control percibido en el bloque de ansiedad; los participantes no universitarios ($n = 43$) presentaron efectos de magnitud grande en culpa interna, $d = 0.97$, y control percibido, $d = 1.15$, en el bloque de depresión.

Discusión

Replicación del Efecto Bélico-Viaje en Depresión

Los resultados del bloque de depresión replican el patrón detallado en el trabajo de Hendricks et al. (2018) y, en algunas variables, lo amplifican. La mayor atribución de culpa interna ante la no recuperación mediante el marco bélico reafirma que, cuando la depresión se conceptualiza como combate, se desencadena en el receptor la idea de que el desenlace negativo implica una derrota personal. En lo que refiere al juicio social negativo atribuido al entorno, presentó el efecto más intenso del estudio: el marco bélico activa la representación del sujeto como agente cuya fortaleza o debilidad será evaluada por los demás, siendo esta la dimensión central de los modelos contemporáneos sobre la perpetuación de las inequidades en salud mental (Pescosolido, 2013; Pescosolido et al., 2013). Un cambio metafórico produce así un desplazamiento significativo en una variable cuya relación con la búsqueda de ayuda profesional es directa.

El mismo esquema victoria-derrota explica los efectos sobre búsqueda de apoyo y aceptación: el rol de combatiente activa connotaciones de autosuficiencia que entran en

tensión con la admisión de vulnerabilidad implícita en pedir ayuda y no deja margen para concebir la asunción del malestar sin equipararla a una rendición, mientras que el marco de viaje admite acompañantes y etapas sin comprometer la identidad del protagonista. El control percibido, tal y como se predijo, resultó mayor exclusivamente bajo el marco de guerra, lo cual se ajusta a la lógica de que quien combate puede actuar sobre su adversario. Este resultado desplaza el foco desde la pregunta sobre el valor beneficioso o perjudicial de la metáfora bélica hacia la de qué dimensiones psicológicas activa simultáneamente y cómo se ponderan según el momento del proceso clínico, el perfil del paciente y los objetivos terapéuticos, en consonancia con la propuesta de los menús metafóricos (Demmen et al., 2015; Semino et al., 2017).

Extensión del Paradigma al Dominio de la Ansiedad

La principal contribución original del estudio reside en la demostración de que el enmarcado metafórico se produce también en el dominio de la ansiedad. La transferencia del binomio batalla-viaje habría sido metodológicamente incoherente, ya que ambas metáforas tienen una estructura orientada a un final, mientras que la ansiedad no se experimenta culturalmente como un proceso biopsicosocial con principio, tratamiento y desenlace, sino como un estado crónico fluctuante, tal y como documentaron Penninx et al. (2011). Las metáforas parásito y semilla se seleccionaron precisamente para preservar dicha cronicidad, describiendo un huésped alojado persistentemente en el protagonista a la vez que activan esquemas opuestos en agencia y valencia.

Los efectos significativos en aceptación, control percibido y búsqueda de apoyo, equiparables a los del bloque de depresión en magnitud y dirección, avalan su viabilidad. El resultado evidencia que el enmarcado no se limita a activar connotaciones sedimentadas en metáforas convencionales, sino que forma un mecanismo general de transferencia de inferencias entre dominios, siempre que se mantenga el isomorfismo estructural, en consonancia con Thibodeau et al. (2017).

La ausencia de significación en las variables culpa interna y juicio social permiten una interpretación teórica coherente. El marco de parásito sitúa al sujeto como huésped invadido de manera involuntaria, restándole responsabilidad; la semilla, en cambio, admite una doble lectura, como germinación espontánea, que reduce la culpa, o como cultivo deliberado, que la incrementa. Dicha ambivalencia probablemente diluyó el contraste entre variables.

La Persuasión Encubierta y sus Marcadores Psicolingüísticos

El tercer eje de hallazgos es posiblemente el de mayor valor teórico. Conciernen al mecanismo a través del cual el enmarcado ejerce su influencia. La convergencia entre las atribuciones, los marcadores psicolingüísticos y la reproducción léxica caracteriza el propio fenómeno como una persuasión encubierta, operada mayoritariamente por la ruta periférica en el sentido de los modelos de doble proceso de la persuasión (Petty y Cacioppo, 1986). En términos generales, el 96.4% de los participantes en el bloque de depresión y el 98.2% en el de ansiedad no aludieron al lenguaje del estímulo al justificar sus respuestas, lo que constituye una medida directa de la inconsciencia del enmarcado. De entre ellos, en torno a un tercio (37.1% y 35.9% del total) construyó atribuciones alternativas explícitas a fuentes personales (creencias generales, inferencias sobre el caso o experiencia propia y cercana), configurando el patrón canónico de persuasión encubierta descrito por Thibodeau y Boroditsky (2013) y trasladándolo al ámbito de la salud mental y a una muestra hispanohablante. La metáfora no opera como un argumento al que se pueda someter a juicio, sino como un andamiaje conceptual a partir del que se empieza a estructurar la representación del dominio meta, aún antes de que se produzca la formación del juicio: persuade en la medida en que no es reconocida como instrumento de persuasión. Estos datos confirman la hipótesis H11: la mayoría de los participantes no atribuyó su juicio al texto ni a la metáfora, sino a fuentes personales.

La correlación negativa de la densidad de verbos cognitivos, situada en el umbral de la significación convencional ($p = -0.151$; $p = .054$), se ajusta al *Elaboration Likelihood Model* como tendencia en la dirección predicha: aquel individuo que verbaliza metacognitivamente su juicio mantiene una distancia entre el mensaje y su evaluación, protegiéndose del desplazamiento metafórico; que dicha asociación se mantenga independientemente del nivel educativo sugiere que la disposición al procesamiento elaborativo no se reduce a la educación formal. La invocación de creencias generales evoca, a su vez, al *Common-Sense Model* (Leventhal et al., 2016): un esquema cognitivo consolidado sobre el trastorno permite integrar el mensaje metafórico en lugar de depender de él. Finalmente, la reproducción del léxico bélico en ambas condiciones de depresión, frente a la prácticamente ausencia de reproducción de los campos de parásito y semilla, confirma que el primero es la opción por defecto del discurso público en español y los segundos, marcos novedosos potentes para condicionar el juicio pero no asentados en el repertorio espontáneo.

En la misma línea, la diversidad léxica (Guiraud) mostró una correlación negativa significativa con el índice de persuasión en ansiedad ($\rho = -0.160$; $p = .041$), lo que sugiere que respuestas más variadas léxicamente, indicadoras de un procesamiento más elaborado, se asociaron a menor susceptibilidad al enmarcado; la ausencia de este patrón en depresión aconseja interpretarlo con cautela y replicarlo en muestras más amplias.

La hipótesis H12 recibe así un respaldo parcial: la densidad de verbos cognitivos y la mención de creencias generales correlacionaron negativamente con la magnitud individual de persuasión en la dirección predicha, con significación plena para las creencias generales en ansiedad ($d = -0.47$, $p = .004$) y tendencias marginales en el resto, mientras que la longitud de la respuesta, también incluida en H12, no alcanzó significación en ningún bloque.

Diferencias Individuales y Asimetrías de la Moderación

Dado el tamaño de algunos subgrupos, los análisis exploratorios de moderación evidencian cuatro patrones que deben ser interpretados como generadores de hipótesis.

El primero es que el sexo no modifica la magnitud global del efecto sino que redistribuye su peso entre variables: las mujeres mostraron efectos mayores en las variables de carga moral (juicio social y culpa interna) y los hombres en las de agencia conductual (control percibido, búsqueda de apoyo y aceptación). Dicha asimetría es coherente con las diferencias de socialización del malestar emocional, históricamente más próxima en las mujeres al lenguaje de la responsabilidad afectiva y la evaluación social (Ferguson y Eyre, 2000; Zahn-Waxler, 2000) y en los hombres al del rendimiento y la autosuficiencia (Addis y Mahalik, 2003).

El segundo es una asimetría generacional exclusiva de la ansiedad, donde los participantes más jóvenes replicaron cuatro de las cinco hipótesis y los de mayor edad ninguna. Al no haberse consolidado los trastornos de ansiedad como categorías diagnósticas diferenciadas hasta el DSM-III (Crocq, 2017; Horwitz, 2010) y al haber permanecido durante décadas subsumidos en el marco de las neurosis, los participantes mayores disponen de un esquema cognitivo menos consolidado sobre el que la metáfora pueda actuar, mientras que los más jóvenes han crecido en un contexto en el que la ansiedad opera como categoría sociocultural de referencia.

El tercero, el más productivo desde una perspectiva teórica, refiere a la experiencia personal con el trastorno. En el bloque de depresión, los participantes sin experiencia

replicaron los efectos, y los participantes con experiencia no alcanzaron significación. Ello encaja con el papel protector de las creencias generales, pues ambos remiten al mismo constructo (la disponibilidad de una representación cognitiva consolidada) y al mecanismo de ancla descrito por el *Common-Sense Model* (Leventhal et al., 2016). Por su parte, el bloque de ansiedad añade un matiz. En el caso de la semilla los que tenían experiencia mostraron un efecto inverso al hipotetizado en culpa interna. La interpretación plausible recoge la doble interpretación de la metáfora desarrollada anteriormente, pues para ellos evocó el cultivo (un proceso que requiere gestión y responsabilidad) y no la germinación espontánea. De ahí la implicación clínica de que las metáforas útiles en la psicoeducación dirigida a población general pueden ser inapropiadas, e incluso contraproducentes, para quienes conviven con el trastorno.

El cuarto patrón es el más contraintuitivo: ni la formación en psicología ni el nivel educativo de los participantes sirvieron de protección frente al enmarcado, y entre los participantes con formación el efecto sobre la culpa interna en depresión fue incluso de mayor magnitud. Esto sugiere que el conocimiento técnico declarativo y la conciencia metacognitiva de cómo el lenguaje determina la forma en la que se percibe la realidad son recursos separados, y que solo el segundo atenúa el efecto: al no percibirse la metáfora como amenaza, no se activa como red de defensa el conocimiento técnico, e incluso puede que, al proporcionar al sujeto de redes semánticas más densas, se amplifique la gama de material sobre el que se apoya la metáfora.

Implicaciones Aplicadas

Los hallazgos abren la puerta a aplicaciones en cuatro niveles. En el ámbito de la comunicación clínica y la psicoeducación, refuerzan la conveniencia de formar a los profesionales en las consecuencias inferenciales de cada metáfora y en su capacidad persuasiva encubierta. Puesto que el marco bélico tiende a aumentar la culpa y el juicio social así como a reducir la búsqueda de apoyo, resulta recomendable disponer del marco del viaje como posible alternativa y combinar ambos marcos según el momento terapéutico; el repertorio se amplía con las metáforas de parásito (útil en fases iniciales para externalizar el trastorno) y de semilla (orientada a integrar la experiencia como crecimiento personal en fases avanzadas).

En el contexto de las campañas de salud pública y de mitigación del estigma, la magnitud del efecto sobre el juicio social en depresión, junto a su carácter encubierto, sugiere que modificar el lenguaje de los materiales informativos y del discurso mediático es un recurso de intervención digno de consideración. Además, dado que el receptor común no reconoce la influencia que ejerce este lenguaje sobre sus juicios, no se resistirá activamente a un cambio léxico.

Del mismo modo en la formación universitaria en psicología, los resultados justifican incorporar contenidos sobre pragmática del lenguaje clínico y análisis crítico del discurso, así como entrenamiento en metacognición, dado que es la disposición a procesar el mensaje metacognitivamente, y no el conocimiento técnico, lo que protege frente al enmarcado. La alfabetización metafórica, entendida como la capacidad de detectar y analizar críticamente los marcos presentes en el discurso sobre la salud mental, constituye así un objetivo formativo valioso.

Conclusiones

El estudio se planteó tres objetivos: replicar el efecto del enmarcado batalla-viaje sobre la depresión en muestra hispanohablante, extenderlo a la ansiedad mediante metáforas de elaboración propia, y examinar su carácter encubierto. Los tres obtuvieron respaldo empírico.

El bloque de depresión replicó los efectos originales de Hendricks et al. (2018) en las cinco variables dependientes ($d = 0.36-0.82$), confirmando que el fenómeno es transversal cultural y lingüísticamente. Las metáforas de parásito y semilla, diseñadas para preservar el isomorfismo estructural en un dominio de curso crónico, produjeron efectos significativos en tres de las cinco variables de ansiedad ($d = 0.34-0.52$), mostrando que el enmarcado funciona mediante transferencia de inferencias entre dominios conceptuales, con independencia de la familiaridad del receptor con la metáfora. El efecto operó de forma mayoritariamente encubierta, pues solo entre el 1.8% y el 3.6% de los participantes reconocieron el papel del lenguaje, y se asoció, en el bloque de depresión, a una menor susceptibilidad en quienes mostraron mayor densidad de verbos cognitivos como tendencia marginal, y en el bloque de ansiedad a quienes invocaron creencias generales sobre el trastorno, patrones en línea con el *Elaboration Likelihood Model* y el *Common-Sense Model* respectivamente. Los análisis exploratorios apuntan a que el sexo redistribuye el peso del efecto en lugar de la propia

magnitud, además de a una asimetría generacional en ansiedad atribuible a la disponibilidad cognitiva del concepto, al papel protector de la experiencia personal con el trastorno y a la ausencia de papel protector frente a la persuasión de la formación técnica sobre el ámbito.

En conjunto, los resultados reafirman que describir un trastorno mental es configurarlo cognitivamente para el receptor sin que este reconozca el efecto. La elección de las metáforas es, más que un accesorio, un determinante encubierto y medible de cómo los trastornos se perciben, juzgan y viven, con implicaciones directas para la comunicación clínica, la psicoeducación, las campañas de mitigación del estigma y la formación universitaria en psicología.

Limitaciones del Estudio

Los hallazgos se han de interpretar considerando las siguientes limitaciones metodológicas. En primer lugar, al realizarse un muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve a través de redes sociales y mensajería instantánea, se produjo una muestra con sesgo de autoselección y sobrerrepresentación de participantes con estudios universitarios, lo que limita la generalización a la población general. En segundo lugar, la asignación de los marcos metafóricos en función de la paridad del mes de nacimiento produjo grupos de tamaño desigual que reducen la potencia estadística a pesar de ser cuasi-aleatoria y libre de autoselección. La tercera comprende la operacionalización de las variables dependientes mediante un único ítem por constructo, pues aunque replica el estudio original, limita la fiabilidad de cada medida. En cuarta posición se contempla la codificación de las categorías de atribución y el análisis de contenido asociado. Aunque el procedimiento se apoyó en listas léxicas definidas a priori y aplicadas de forma sistemática mediante AntConc 4.2.4, lo que garantiza su replicabilidad, no se llevó a cabo una codificación con dos o más jueces independientes ni se calculó un índice de acuerdo inter-jueces (p. ej., kappa de Cohen). En consecuencia, los resultados del análisis de contenido y, en particular, los hallazgos de magnitud pequeña-media, deben interpretarse con cautela y requieren replicación con codificación inter-jueces en muestras independientes. La quinta limitación nace del hecho de que los participantes leyeron primero el bloque de depresión y luego el de ansiedad, puesto que introduce un posible efecto de transferencia que un contrabalanceado permitiría descartar. La sexta y última se constituye de que los análisis de las variables moderadoras son meramente exploratorios, y el reducido tamaño de ciertos subgrupos junto a la ausencia de

corrección por comparaciones múltiples obliga a considerar las asimetrías como hipótesis para investigación futura.

Finalmente, como se señala en la sección de Análisis de Datos, el solapamiento parcial entre las categorías de verbos cognitivos y creencias generales sobre el trastorno constituye una limitación del análisis psicolingüístico que aconseja interpretar esos resultados con cautela.

Líneas Futuras de Investigación

Los resultados obtenidos proponen seis líneas de investigación. La primera consiste en extender el paradigma a trastornos con perfiles fenomenológicos distintos, tales como el trastorno obsesivo-compulsivo, el bipolar, los de la conducta alimentaria o los psicóticos, lo que permitiría determinar en qué medida el enmarcado opera de forma homogénea en función de las características del dominio meta. Una línea complementaria a ello consiste en diseñar estudios que estratifiquen la muestra a priori según la historia de salud mental de los participantes, constituyendo grupos diferenciados de personas con y sin experiencia diagnóstica o de tratamiento en cada trastorno, con un tamaño suficiente en cada subgrupo para contrastar de forma confirmatoria, y no meramente exploratoria, los efectos del enmarcado por separado en cada uno. Ello permitiría determinar con precisión hasta qué punto la representación cognitiva consolidada del trastorno protege frente a la persuasión metafórica e identificar para qué perfiles ciertas metáforas resultan beneficiosas o contraproducentes.

La segunda es el refinamiento del análisis psicolingüístico utilizando herramientas estandarizadas y validadas, codificación inter-jueces y validación cruzada con análisis manual. La tercera propone la elaboración y evaluación de diseños conductuales que trasladen los hallazgos a decisiones reales, traduciendo el efecto a tasas de búsqueda de ayuda, adherencia o conductas de apoyo. La cuarta consiste en el desarrollo y evaluación de programas de alfabetización metafórica y metacognición lingüística dirigidos a profesionales, pacientes y población general, y la quinta, por último, refiere a la replicación transcultural del paradigma, lo que permitiría distinguir qué efectos son universales y cuáles dependen de las asociaciones que cada metáfora activa en cada lengua y comunidad. La sexta, de carácter metodológico, propone explorar el análisis psicolingüístico de las justificaciones producidas por los participantes como herramienta de evaluación clínica. El principio del Reality Monitoring (Johnson y Raye, 1981) postula que las representaciones de origen interno

contienen más inferencias y marcadores metacognitivos que las de origen externo; extrapolado al contexto clínico, este principio sugiere que el análisis automatizado del lenguaje producido por un paciente al describir su trastorno podría aportar información sobre el origen y la consolidación de sus representaciones cognitivas del mismo. Investigación futura podría examinar si la densidad de verbos cognitivos y la invocación espontánea de representaciones previas predicen la susceptibilidad al enmarcado terapéutico, y si dichos marcadores son sensibles a intervenciones basadas en la narrativa y la reestructuración cognitiva.

Referencias

- Addis, M. E., & Mahalik, J. R. (2003). Men, masculinity, and the contexts of help seeking. *American Psychologist*, 58(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.58.1.5>
- Anthony, L. (2023). *AntConc (Versión 4.2.4) [Software de cómputo]*. Waseda University. <https://www.laurenceanthony.net/software>
- Bardin, L. (2002). *Análisis de contenido* (C. Suárez, Trad.; 3.^a ed.). Akal. (Trabajo original publicado en 1977)
- Confederación Salud Mental España, & Fundación Mutua Madrileña. (2023). *La situación de la salud mental en España*. Confederación Salud Mental España. <https://consaludmental.org/centro-documentacion/estudio-situacion-salud-mental/>
- Crocq, M.-A. (2017). The history of generalized anxiety disorder as a diagnostic category. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 19(2), 107–116. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2017.19.2/macrocq>
- Demmen, J., Semino, E., Demjén, Z., Koller, V., Hardie, A., Rayson, P., & Payne, S. (2015). A computer-assisted study of the use of violence metaphors for cancer and end of life by patients, family carers and health professionals. *International Journal of Corpus Linguistics*, 20(2), 205–231. <https://doi.org/10.1075/ijcl.20.2.03dem>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Ferguson, T. J., & Eyre, H. L. (2000). Engendering gender differences in shame and guilt: Stereotypes, socialization, and situational pressures. En A. H. Fischer (Ed.), *Gender and emotion: Social psychological perspectives* (pp. 254–276). Cambridge University Press.
- Garcia-Retamero, R., & Galesic, M. (2010). How to reduce the effect of framing on messages about health. *Journal of General Internal Medicine*, 25(12), 1323–1329. <https://doi.org/10.1007/s11606-010-1484-9>
- Hendricks, R. K., Demjén, Z., Semino, E., & Boroditsky, L. (2018). Emotional implications of metaphor: Consequences of metaphor framing for mindset about cancer. *Metaphor and Symbol*, 33(4), 267–279. <https://doi.org/10.1080/10926488.2018.1549835>
- Horwitz, A. V. (2010). How an age of anxiety became an age of depression. *The Milbank Quarterly*, 88(1), 112–138. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2010.00591.x>
- JASP Team. (2026). *JASP (Versión 0.97) [Software de cómputo]*. <https://jasp-stats.org/>

- Johnson, M. K., & Raye, C. L. (1981). Reality monitoring. *Psychological Review*, 88(1), 67–85. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.1.67>
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Leventhal, H., Phillips, L. A., & Burns, E. (2016). The Common-Sense Model of Self-Regulation (CSM): A dynamic framework for understanding illness self-management. *Journal of Behavioral Medicine*, 39(6), 935–946. <https://doi.org/10.1007/s10865-016-9782-2>
- Penninx, B. W. J. H., Nolen, W. A., Lamers, F., Zitman, F. G., Smit, J. H., Spinhoven, P., Cuijpers, P., de Jong, P. J., van Marwijk, H. W. J., van der Meer, K., Verhaak, P., Laurant, M. G. H., de Graaf, R., Hoogendijk, W. J., van der Wee, N., Ormel, J., van Dyck, R., & Beekman, A. T. F. (2011). Two-year course of depressive and anxiety disorders: Results from the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA). *Journal of Affective Disorders*, 133(1–2), 76–85. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.03.027>
- Pescosolido, B. A. (2013). The public stigma of mental illness: What do we think; what do we know; what can we prove? *Journal of Health and Social Behavior*, 54(1), 1–21. <https://doi.org/10.1177/0022146512471197>
- Pescosolido, B. A., Medina, T. R., Martin, J. K., & Long, J. S. (2013). The “backbone” of stigma: Identifying the global core of public prejudice associated with mental illness. *American Journal of Public Health*, 103(5), 853–860. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.301147>
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of persuasion. En L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 19, pp. 123–205). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60214-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60214-2)
- Ramírez-Esparza, N., Pennebaker, J. W., García, F. A., & Suriá, R. (2007). La psicología del uso de las palabras: Un programa de computadora que analiza textos en español. *Revista Mexicana de Psicología*, 24(1), 85–99.
- Semino, E., Demjén, Z., Demmen, J., Koller, V., Payne, S., Hardie, A., & Rayson, P. (2017). The online use of Violence and Journey metaphors by patients with cancer, as compared with health professionals: A mixed methods study. *BMJ Supportive & Palliative Care*, 7(1), 60–66. <https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2014-000785>
- Sontag, S. (2003). *La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas*. Taurus. (Trabajo original publicado en 1979)

- Steen, G. J. (2023). *Slowing metaphor down: Elaborating deliberate metaphor theory*. John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/celcr.26>
- Tabesh, P., Tabesh, P., & Moghaddam, K. (2019). Individual and contextual influences on framing effect: Evidence from the Middle East. *Journal of General Management*, 45(1), 30–39. <https://doi.org/10.1177/0306307019851337>
- Tausczik, Y. R., & Pennebaker, J. W. (2010). The psychological meaning of words: LIWC and computerized text analysis methods. *Journal of Language and Social Psychology*, 29(1), 24–54. <https://doi.org/10.1177/0261927X09351676>
- Thibodeau, P. H., & Boroditsky, L. (2011). Metaphors we think with: The role of metaphor in reasoning. *PLoS ONE*, 6(2), e16782. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016782>
- Thibodeau, P. H., & Boroditsky, L. (2013). Natural language metaphors covertly influence reasoning. *PLoS ONE*, 8(1), e52961. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052961>
- Thibodeau, P. H., Hendricks, R. K., & Boroditsky, L. (2017). How linguistic metaphor scaffolds reasoning. *Trends in Cognitive Sciences*, 21(11), 852–863. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.07.001>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458. <https://doi.org/10.1126/science.7455683>
- Tweedie, F. J., & Baayen, R. H. (1998). How variable may a constant be? Measures of lexical richness in perspective. *Computers and the Humanities*, 32(5), 323–352. <https://doi.org/10.1023/A:1001749303137>
- Xu, L. (2024). Advanced age predicts increased susceptibility to attribute, goal, and risky-choice framing in negative frame valences. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, Article 217. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02658-6>
- Zahn-Waxler, C. (2000). The development of empathy, guilt, and internalization of distress: Implications for gender differences in internalizing and externalizing problems. En R. J. Davidson (Ed.), *Anxiety, depression, and emotion* (pp. 222–265). Oxford University Press.

Anexo A

Viñetas Experimentales

A continuación se reproducen las cuatro viñetas empleadas como estímulo experimental, organizadas por bloque y condición. En cada una de ellas, los términos correspondientes al núcleo metafórico aparecen en negrita a efectos exclusivamente expositivos; en la versión administrada a los participantes los textos se presentaron sin marcado tipográfico alguno. Las viñetas del bloque de depresión constituyen una traducción adaptada del estímulo empleado por Hendricks et al. (2018, Experimento 5), mientras que las viñetas del bloque de ansiedad son de elaboración propia.

Bloque 1. Depresión

Condición A. Marco bélico (Batalla)

*“A Marcos le acaban de diagnosticar depresión. Sabe que, en un futuro próximo, cada día será una **batalla** contra la enfermedad. La **lucha** que tiene que **librar** no siempre será fácil. Muchas personas han escrito sobre sus experiencias en el **campo de batalla**, y él puede acudir a ellas en busca de consuelo. Sus amigos y familiares quieren que sepa que no estará solo en su **lucha**. Aunque a veces puede que no tenga ganas de hablar, otras veces querrá compartir sus historias de **batalla** con los demás, y ellos estarán ahí en esos momentos.”*

Condición B. Marco del recorrido (Viaje)

*“A Marcos le acaban de diagnosticar depresión. Sabe que, en un futuro próximo, cada día será un **viaje** con la enfermedad. El **camino** que tiene que **recorrer** no siempre será fácil. Muchas personas han escrito sobre sus experiencias en el **sendero**, y él puede acudir a ellas en busca de consuelo. Sus amigos y familiares quieren que sepa que no estará solo en su **viaje**. Aunque a veces puede que no tenga ganas de hablar, otras veces querrá compartir sus historias de **viaje** con los demás, y ellos estarán ahí en esos momentos.”*

Bloque 2. Ansiedad

Condición A. Marco del parásito

*“Laura tiene ansiedad. Lo que esto significa, en su día a día, es que convive con un **parásito**: algo que vive dentro de ella alimentándose de su energía, que avanza cuando ella está agotada y que retrocede sin avisar. No siempre es posible saber cuándo el **organismo que la invade** va a extenderse ni cuándo va a ceder, y esa incertidumbre forma parte de la **infección**. Quienes la quieren le han dicho que no va a atravesar este **contagio** sola, y aunque hay días en que prefiere el silencio, también los hay en que necesita hablar de lo que es cargar con este **parásito**, y sabe que tendrá a alguien dispuesto a escucharla.”*

Condición B. Marco de la semilla

*“Laura tiene ansiedad. Lo que esto significa, en su día a día, es que convive con una **semilla**: algo que vive dentro de ella alimentándose de su energía, que crece cuando ella está agotada y que se detiene sin avisar. No siempre es posible saber cuándo el **organismo que la habita** va a extenderse ni cuándo va a ceder, y esa incertidumbre forma parte del **cultivo**. Quienes la quieren le han dicho que no va a atravesar este **crecimiento** sola, y aunque hay días en que prefiere el silencio, también los hay en que necesita hablar de lo que es cargar con esta **semilla**, y sabe que tendrá a alguien dispuesto a escucharla.”*

Anexo B

Cuestionario Completo

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del cuestionario administrado a los participantes a través de la plataforma Google Forms. La presentación visual del original incluía saltos condicionales que dirigían al participante al bloque experimental correspondiente en función de su respuesta al ítem inicial sobre el mes de nacimiento; dichos saltos se reflejan aquí mediante anotaciones tipográficas.

Información Inicial y Consentimiento Informado

“Estudio sobre la percepción de la salud. Este estudio forma parte de un Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Sevilla. El objetivo es analizar cómo las personas procesan diferentes situaciones de salud. A continuación, leerás dos breves relatos y responderás a unas preguntas de opinión sobre cada uno. Para terminar, completarás unos breves datos generales para el análisis estadístico del estudio. Duración estimada: 5 minutos.”

“Privacidad y Derechos. La participación es totalmente anónima; no se recogen datos que permitan tu identificación. Los datos se tratarán con fines exclusivamente estadísticos y académicos. Tu participación es voluntaria y puedes abandonar el cuestionario en cualquier momento. Al hacer clic en ‘Siguiente’, confirmas ser mayor de edad y otorgas tu consentimiento para participar.”

Asignación de Grupo

Ítem 1. ¿Es tu mes de nacimiento par o impar? Opciones: A) Par; B) Impar.

Los participantes que respondieron par fueron dirigidos a las viñetas correspondientes a las condiciones bélica y parásito. Los participantes que respondieron impar fueron dirigidos a las viñetas correspondientes a las condiciones del recorrido y semilla.

Bloque 1. Depresión (Marcos)

Tras la lectura de la viñeta correspondiente (Anexo A), los participantes respondieron a los siguientes cinco ítems en escala Likert de siete puntos y a una pregunta abierta obligatoria de justificación.

Ítem 2 (Batalla) / Ítem 14 (Viaje). Si Marcos no se recupera, ¿en qué medida crees que sentirá que no hizo lo suficiente? Anclajes: 1 = Nada - 7 = Completamente.

Ítem 3 (Batalla) / Ítem 15 (Viaje). ¿En qué medida crees que Marcos podrá hacer las paces con su situación? Anclajes: 1 = Nada - 7 = Completamente.

Ítem 4 (Batalla) / Ítem 16 (Viaje). ¿Hasta qué punto crees que Marcos siente que tiene control sobre el curso de su enfermedad? Anclajes: 1 = Ningún control - 7 = Control total.

Ítem 5 (Batalla) / Ítem 17 (Viaje). ¿En qué medida crees que Marcos buscaría apoyo emocional en su entorno? Anclajes: 1 = Muy poco - 7 = Muchísimo.

Ítem 6 (Batalla) / Ítem 18 (Viaje). ¿Crees que si Marcos no mejora, la gente de su entorno pensará que no se esforzó lo suficiente? Anclajes: 1 = Nada probable - 7 = Muy probable.

Ítem 7 (Batalla) / Ítem 19 (Viaje). Pregunta abierta. Explica brevemente por qué has elegido esas respuestas.

Bloque 2. Ansiedad (Laura)

Tras la lectura de la viñeta correspondiente (Anexo A), los participantes respondieron a los siguientes cinco ítems en escala Likert de siete puntos y a una pregunta abierta obligatoria de justificación.

Ítem 8 (Parásito) / Ítem 20 (Semilla). ¿En qué medida crees que Laura siente que su ansiedad es consecuencia de algo que ella misma provocó? Anclajes: 1 = Nada - 7 = Completamente.

Ítem 9 (Parásito) / Ítem 21 (Semilla). ¿En qué medida crees que Laura podrá hacer las paces con el hecho de tener ansiedad? Anclajes: 1 = Nada - 7 = Completamente.

Ítem 10 (Parásito) / Ítem 22 (Semilla). ¿Hasta qué punto crees que Laura siente que puede influir en el curso de su ansiedad? Anclajes: 1 = Ningún control - 7 = Control total.

Ítem 11 (Parásito) / Ítem 23 (Semilla). ¿En qué medida crees que Laura buscaría apoyo emocional en su entorno cercano? Anclajes: 1 = Muy poco - 7 = Muchísimo.

Ítem 12 (Parásito) / Ítem 24 (Semilla). Si Laura no mejora, ¿en qué medida crees que la gente de su entorno pensará que no hizo lo suficiente? Anclajes: 1 = Nada probable - 7 = Muy probable.

Ítem 13 (Parásito) / Ítem 25 (Semilla). Pregunta abierta. Explica brevemente por qué has elegido esas respuestas.

Bloque 3. Datos Sociodemográficos

Todos los participantes, con independencia de la condición experimental, completaron al final del cuestionario los siguientes seis ítems.

Ítem 26. Edad. Respuesta abierta numérica.

Ítem 27. Sexo. Opciones: Hombre; Mujer; Prefiero no decirlo.

Ítem 28. Nivel de estudios completado. Opciones: Educación primaria; Educación secundaria (ESO); Bachillerato o FP de grado medio; FP de grado superior; Grado universitario en curso; Grado universitario finalizado; Máster o posgrado; Doctorado.

Ítem 29. ¿Has sido diagnosticado/a o tratado/a por depresión en algún momento? Opciones: Sí; No; Prefiero no decirlo.

Ítem 30. ¿Has sido diagnosticado/a o tratado/a por ansiedad en algún momento? Opciones: Sí; No; Prefiero no decirlo.

Ítem 31. ¿Tienes formación previa en psicología o salud mental? Opciones: Sí; No.

Anexo C

Categorías Léxicas del Análisis Psicolingüístico

Se reproducen a continuación las listas léxicas utilizadas en el análisis de contenido categorial y en el análisis psicolingüístico cuantitativo de las respuestas textuales descritos en la sección de Análisis de Datos. Estas listas, definidas a priori a partir del marco teórico, sirvieron de base para la identificación sistemática de los marcadores correspondientes a cada categoría mediante el software AntConc 4.2.4 (Anthony, 2023). En todas las búsquedas se aplicó coincidencia insensible a mayúsculas y se admitieron variantes flexivas de cada término (singular, plural, formas verbales conjugadas) cuando resultaba pertinente.

Categorías de Atribución de la Fuente del Juicio

Atribución al texto, la metáfora o el lenguaje

texto, relato, enunciado, descripción, lenguaje, palabras, términos, expresiones, metáforas, frase, narrativa, narración, cómo se describe, cómo se cuenta, cómo está presentado, cómo está redactado, cómo está escrito, cómo está expresado, según lo que dice, por lo que cuenta, por lo que describe, por lo que se lee, por las expresiones del relato.

Atribución a experiencia personal con el trastorno

mi experiencia, por mi experiencia, hablo de experiencia propia, propia experiencia, propia vivencia, lo he vivido en primera persona, en primera persona, yo lo he pasado, yo lo he sufrido, yo lo he vivido, tengo depresión, tengo ansiedad, tuve depresión, tuve ansiedad, he tenido depresión, he tenido ansiedad, soy diagnosticado, fui diagnosticada, padezco depresión, padezco ansiedad, sufro depresión, sufro ansiedad.

Atribución a experiencia con personas cercanas

gente que conozco, personas que conozco, familia, amigos, amigas, conocidos, conocidas, seres queridos, mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo, mi pareja, mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, mi abuela, mi abuelo, conozco gente, conozco personas, conozco a alguien, sé de gente, sé de personas, alguien cercano, gente cercana, familiares.

Atribución a creencias generales sobre el trastorno

creo que, pienso que, considero, en mi opinión, para mí, la depresión es, la depresión suele, la depresión tiene, la depresión provoca, la depresión conlleva, la ansiedad es, la ansiedad suele, la ansiedad tiene, la ansiedad provoca, la ansiedad conlleva, este tipo de enfermedad, este tipo de trastorno, es muy común, es bastante común, es muy frecuente, es bastante frecuente, es típico, la gente suele, la gente tiende, la gente piensa, en general, normalmente, habitualmente, por lo general, una enfermedad mental, un trastorno psicológico, estigma, prejuicio, sociedad.

Inferencias directas sobre el caso del protagonista

Marcos siente, Marcos piensa, Marcos cree, Marcos tiene, Marcos sentiría, Marcos pensaría, Marcos debería, Marcos necesita, Marcos busca, Laura siente, Laura piensa, Laura cree, Laura tiene, Laura sentiría, Laura pensaría, Laura debería, Laura necesita, Laura busca, siento que Marcos, siento que Laura, me parece que Marcos, me parece que Laura, su entorno, su familia, su gente, su caso, él siente, ella siente, él piensa, ella piensa.

Léxico de los Marcos Metafóricos

Marco bélico (Batalla)

batalla, batallar, lucha, luchar, luchando, luchas, combate, combatir, guerra, guerrear, enemigo, adversario, enfrentar, enfrentamiento, enfrentarse, vencer, derrota, derrotar, victoria, librar, trinchera, frente, atacar, defender, defensa, resistir, sobrevivir, conquistar, conquista, combatiente, soldado, luchador, derrotado, vencido, vencedor.

Marco del recorrido (Viaje)

viaje, viajar, camino, caminar, caminando, sendero, recorrer, recorrido, trayecto, trayectoria, travesía, atravesar, etapa, etapas, jornada, ruta, destino, pasaje, cruzar, avanzar, progresar, paso a paso, andar.

Marco parasitario

parásito, parásitos, invasión, invadir, invadido, invadiendo, infección, infecta, infectar, contagio, contagiar, contagioso, huésped, consumir, consumiendo, organismo que invade, organismo invasor, enfermar, patología, microbio, bicho, veneno.

Marco de la semilla

semilla, semillas, cultivar, cultivo, crecer, crecimiento, brotar, brote, germinar, germinación, florecer, florecimiento, jardín, jardinera, plantar, raíces, sembrar, siembra, fruto, frutos, abonar, regar.

Categorías Psicolingüísticas

Verbos cognitivos

creo, pienso, considero, opino, supongo, imagino, entiendo, asumo, sospecho, juzgo.

Marcadores de certeza

sé, sabemos, seguro, segura, claramente, obvio, evidente, claro, indudablemente, innegable.

Marcadores de tentatividad

quizá, quizás, tal vez, puede, podría, posiblemente, probablemente, parece, parecería.

Marcadores de causalidad

porque, pues, debido a, a causa de, motivo, razón, provoca, genera, produce, resulta, así, por consiguiente, por tanto, entonces, dado que.

Pronombres en primera persona del singular

yo, me, mí, mi, mío, mía, míos, mías, conmigo.

Pronombres en tercera persona

él, ella, ello, ellos, ellas, le, les, lo, la, los, las, suyo, suya, suyos, suyas, se, sí.

Negaciones

no, nada, nunca, jamás, ningún, ninguna, ninguno, tampoco, ni, sin.

Léxico de emoción negativa

triste, tristeza, pena, dolor, sufrir, sufrimiento, miedo, angustia, desesperación, desesperanza, mal, malo, malestar, deprimido, desolado, angustiado, preocupado, preocupación, agobio, agobiado, estrés, estresado, terror, pánico.

Léxico de emoción positiva

bien, bueno, feliz, felicidad, alegría, contento, contenta, esperanza, esperanzado, positivo, positiva, tranquilo, tranquila, calma, paz, aceptar, aceptación, bienestar, mejora, mejor, fortaleza, fuerte.